

## B 非上皮性成分を含む病変 non-epithelial neoplasms

### 1

#### リンパ増殖性疾患 lymphoproliferative disorders

##### 到達目標

- ・悪性リンパ腫とリンパ増殖性疾患の概念を説明することができる
- ・代表的な肺原発リンパ増殖性疾患を列挙することができる
- ・頻度の高いリンパ増殖性疾患の診断ができ、治療の原則を述べるることができる

##### 主な疾患の分類と臨床的位置づけ

Hodgkin リンパ腫は成熟 B 細胞由来の Hodgkin/Reed–Steinberg 細胞や lymphocyte predominant 細胞の、非 Hodgkin リンパ腫 (NHL) は成熟 T, B, NK 細胞由来の腫瘍と定義される。またこれらの定義に入らないリンパ増殖性疾患 (LPD) がある。従来、LPD は悪性リンパ腫 (ML) を含まない概念であったが、分類に曖昧さが残ることから 2017 年 WHO 分類から LPD には ML が含まれることとなった。特に methotrexate などの免疫調整薬や、移植後免疫抑制薬使用中の発症、Epstein–Barr ウイルス感染による変化は、LPD から ML への進展を明確に分類することが困難である（詳細は各論 I–8. E を参照）。胸部腫瘍の WHO 分類<sup>1)</sup> では mucosa associated lymphoid tissue lymphoma (MALT リンパ腫)、びまん性大細胞型 B 細胞リンパ腫、リンパ腫様肉芽腫 (lymphomatoid granulomatosis)、血管内大細胞型 B 細胞リンパ腫 (intravascular large B-cell lymphoma)、肺 Langerhans 細胞組織球症、Erdheim–Chester 病の 6 疾患が記載されている。前者 4 疾患は B 細胞性 NHL であり、後者 2 疾患は ML に含まれないリンパ増殖性疾患である。本書では NHL は各論 I–8. E で解説され、Langerhans 細胞組織球症は各論 I–8. C で解説されるため詳細はこれらを参照されたい。

Erdheim–Chester 病はまれな非 Langerhans 細胞組織球症の一病型である。泡沫状の組織球の臓器浸潤が特徴的で、ほぼ全例で骨、25～50% で肺病変（縦隔・胸膜浸潤、間質性肺疾患など）が存在する。その他、心血管系、後腹膜、中枢神経系、皮膚などにも病変を認める。約半数に BRAF V600E 変異があり、BRAF 阻害薬に反応することが報告されている。

##### 症候・身体所見

いずれの疾患においても肺病変に伴う、咳嗽、呼吸

困難などの臨床症状を伴うこともあるが、検診などで偶然発見されることもある。

##### 診断・検査

組織検体の病理学的診断が必須であり、免疫組織化学染色、遺伝子検査、フローサイトメトリーなどによる分析も必要となる。

### 2

#### 間葉系腫瘍 mesenchymal tumors

##### 到達目標

- ・代表的な肺間葉系腫瘍を列挙することができる
- ・疾患特異的な融合遺伝子、遺伝子変異との関係を述べるることができる

##### 病因・病態・疫学

胸部腫瘍の WHO 分類<sup>1)</sup> に記載のある主な成人の間葉系腫瘍について概略を表 1 に示す。

##### 症候・身体所見

いずれの疾患においても肺病変に伴う、咳嗽、呼吸困難などの臨床症状を伴うこともあるが、検診などで偶然発見されることもある。

##### 診断・検査

切除標本を含む病理組織学的検討が必要であるが、確定診断にはしばしば疾患特異的な融合遺伝子、遺伝子異常を証明することが必要になる。

##### 治療と予後

疾患により異なる。限局していれば切除が原則であるが、進行・転移例では軟部肉腫と同様、薬物療法（細胞傷害性抗癌薬および分子標的治療薬）や放射線治療を行うが、希少疾患が多く治療に関するエビデンスは不十分である。